



Avaliação Geriátrica Ampla

Definição

É um **instrumento de avaliação multidimensional e interdisciplinar** para realizar um diagnóstico global. A avaliação geriátrica ampla (AGA) é a resposta a essa complexidade e, geralmente, inclui a avaliação do paciente em vários domínios, sendo mais comumente incluídos o físico (médico), o mental, o social, o funcional e o ambiental.

Avalia principalmente funcionalidade e qualidade de vida.

Busca investigar síndrome geriátricas com manifestações atípicas ou ocultas. Geralmente mais focada em buscar formas de prevenir problemas e melhorar a qualidade de vida.

Para facilitar a avaliação geriátrica, são usados instrumentos capazes de detectar sinais de demência, delirium, depressão, efeitos colaterais de medicamentos, fragilidade, déficits visuais e auditivos, bem como de grandes síndromes geriátricas e perda do equilíbrio e da capacidade funcional. Esses instrumentos também são úteis para prever prognóstico, tolerabilidade ao tratamento e riscos de morte e incapacidade.

▼ História

Os princípios básicos da avaliação geriátrica surgiram há mais de 60 anos, no Reino Unido, com a médica inglesa Marjory Warren, que, em 1936, iniciou obstinado trabalho de reabilitação de pacientes incapacitados em um hospital londrino. Muitos deles recuperaram a mobilidade e receberam alta.

O resultado positivo deste trabalho introduziu o conceito do cuidado interdisciplinar e a necessidade de uma avaliação ampla dos pacientes geriátricos, com o objetivo de esquematizar um plano terapêutico.

▼ Qual a diferença entre AGA e uma consulta normal?

- Complementa a anamnese tradicional e melhora a precisão diagnóstica;

- Identifica se há diminuição da capacidade motora e das atividades, causa motora, mental ou psíquica;
- Detecta problemas médicos ocultos;
- Parâmetro funcional e avaliação do declínio.

Entre os benefícios da AGA, demonstrados em diversos estudos, encontram-se: precisão diagnóstica, melhora do estado funcional e mental, melhora do humor, redução da mortalidade, diminuição de internação hospitalar e de institucionalização, diminuição da necessidade de assistência domiciliar, redução do uso de medicamentos e da iatrogenia, diminuição do uso e dos custos do sistema de saúde, além de maior satisfação com o atendimento.

▼ **Constituição da AGA**

É multidisciplinar, multisistêmica, avaliamos:

- | | |
|---|--|
| • Equilíbrio, mobilidade e risco de quedas; | • Estado e risco nutricional; |
| • Função cognitiva; | • Condições socioambientais; |
| • Condições emocionais; | • Polifarmácia e medicações inapropriadas; |
| • Deficiências sensoriais; | • Comorbidades e Multimorbidade. |
| • Capacidade funcional; | |

Função motora

Avaliamos equilíbrio, mobilidade e risco de quedas.

Idosos apresentam com maior frequência sarcopenia (envelhecimento, sedentarismo), instabilidade postural (potencializada por distúrbios como DM), quedas, reflexos lentificados.

A avaliação da função motora compreende:

▼ **Avaliação neurológica básica**

Marcha, ataxia, tremores, bradicinesia, rigidez, tonturas;

▼ **Testes específicos para avaliação da mobilidade**

- **Get Up and Go (levantar e andar)**

- Como fazer: levantar-se da cadeira → ficar em pé → caminhar três metros → girar 180° → voltar para o mesmo local e sentar-se;
- O que avalia: é possível avaliar o equilíbrio do paciente sentado, o equilíbrio durante a marcha e a transferência;
- Classificação: classificado em 5 graus, sendo normal, alteração leve, média, moderada ou grave;
- Limitação: avaliação imprecisa; os escores extremos são mais fáceis (1 e 5), mas os escores intermediários são menos claros.

- **Time to get up and go test**

- Como fazer: levantar-se da cadeira → ficar em pé → caminhar três metros → girar 180° → voltar para o mesmo local e sentar-se. Porém, cronometrado;
- Pode ser útil em pacientes com maior carga de doenças e com menor performance;
- Valor de referência: tempo <10 seg. 10-19s um pouco alterado e >19s é totalmente alterado.

- **Teste de equilíbrio e marcha (Tinetti/Poma BR)**

A grande propensão dos idosos à instabilidade postural e à alteração de marcha aumenta o risco de quedas.

Mais completo, consegue avaliar globalmente a função, tanto equilíbrio quanto mobilidade. Extenso, vários modelos diferentes não validados em uso.

▼ **Sarcopenia**

A presença de sarcopenia interfere no equilíbrio e na mobilidade e consequentemente predispõe a quedas. Portanto, faz-se necessária a identificação deste quadro.

European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), definição em três critérios:

1. Baixa força muscular;

2. Baixa quantidade ou qualidade muscular;

3. Baixo desempenho físico.

Com isso, conseguimos classificar em:

- Apenas critério 1 positivo: sarcopenia provável;
- Critério 1+2: sarcopenia confirmada;
- Critério 1+2+3: sarcopenia grave.

A triagem para sarcopenia pode ser feita utilizando-se o SARC-F, um questionário de cinco itens, de fácil aplicação, que é autorrelatado pelos pacientes.

COMPONENTES	PERGUNTAS	PONTUAÇÃO
Força	Qual é a sua dificuldade em levantar ou carregar 4kg?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muito ou incapaz = 2
Assistência ao caminhar	Qual é a sua dificuldade em caminhar através de um quarto?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muito, com ajuda ou incapaz = 2
Levantar da cadeira	Qual é a sua dificuldade em sair da cama ou da cadeira?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muito ou incapaz sem ajuda = 2
Subir escadas	Qual é a sua dificuldade em subir 10 degraus?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muito ou incapaz = 2
Quedas	Quantas vezes você caiu no último ano?	Nenhuma = 0 1 a 3 quedas = 1 4 ou mais quedas = 2

Se ≥ 4 pontos é preditivo de sarcopenia.

▼ Força muscular

A força muscular é avaliada principalmente pela força de pressão palmar.

- **Força de preensão palmar:**

Analisa força global, são 3 tentativas e analisamos a melhor.

Utiliza-se o dinamômetro manual modelo Jamar, e a técnica é realizada com o indivíduo sentado. O resultado é a média de três medidas realizadas no membro dominante com intervalo de 60 segundos entre cada medida.

Sarcopenia:

- Homens < 27kg;
- Mulheres < 16kg.

▼ Mensuração da massa muscular

A mensuração da massa muscular pode ser feita por meio de métodos antropométricos e/ou da bioimpedância e/ou da densitometria corporal total.

- **Circunferência da panturrilha:**

É a medida antropométrica mais sensível e mais utilizada para avaliação da massa muscular em idosos.

Normal ≥ 31 cm na não dominante.

- **Outros:** RM, TC, US, DXA, bioimpedância.

▼ Desempenho muscular

É avaliado principalmente pelo teste do levantar e andar cronometrado (Timed Up and Go Test), velocidade da marcha e pelo Short Physical Performance Battery (SPPB)

- **Velocidade de Marcha:**

É medida pelo tempo, em segundos e milésimos de segundo, que o indivíduo leva para percorrer 4 metros. O cálculo é feito pela média de três tentativas e avalia o desempenho muscular.

Normal velocidade de marcha $> 0,8$ m/s.

Função cognitiva

A cognição é o processo de aquisição de conhecimento e inclui, entre outras funções cognitivas, atenção, raciocínio, pensamento, memória, juízo, abstração e linguagem.

As alterações cognitivas podem levar a perda de autonomia e a progressiva dependência.

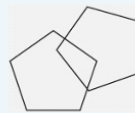
Os rastreios para identificação são rápidos e eficientes.

▼ Testes

- **Mini Exame do Estado Mental (MEEM)**

Importante instrumento de rastreio, de fácil e rápida aplicação, avalia os principais aspectos da função cognitiva.

Orientação temporal (qual é o ... ?)	Ano	5 pontos
	Mês	
	Dia do mês	
	Dia da semana	
	Hora	
Orientação espacial (onde estamos?)	Local específico	5 pontos
	Local genérico	
	Bairro ou rua próxima	
	Cidade	
	Estado	
Memória imediata	Nomear três objetos e pedir ao paciente que repita: “carro, vaso, tijolo”	3 pontos
	Se ele não conseguir, ensinar até aprender, no máximo até 6 vezes	
Atenção e cálculo	Pedir que o paciente diminua 7 de 100 (5 vezes sucessivas)	5 pontos
	Alternativa: soletrar a palavra “mundo” na ordem inversa	
Memória de evocação	Repetir os três objetos nomeados antes	3 pontos
Linguagem	Mostrar um relógio e uma caneta e pedir que os nomeie	2 pontos
	Pedir que repita: “nem aqui, nem ali, nem lá”	1 ponto
	Seguir o comando de três estágios: “pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão	3 pontos
	Ler e executar a ordem: “feche os olhos”	1 ponto
	Escrever uma frase	1 ponto
	Copiar o desenho:	1 Ponto



Alterado se:

- Analfabetos < 20 pontos;
- 1-4 anos de estudo < 25 pontos;
- 5-8 anos de estudo < 26 pontos;
- 9-11 anos de estudo < 28 pontos;
- 11 ou mais anos de estudo < 29 pontos.

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA):

Apresenta alta sensibilidade e alta especificidade para detecção de comprometimento cognitivo leve (CCL), principalmente nos pacientes com desempenho na faixa normal do MEEM.

Melhor para pacientes com alta reserva cognitiva.

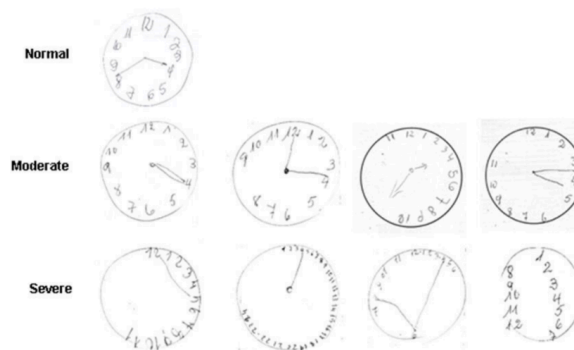
Corte 24/25 pontos no BR com > 4 anos de escolaridade

- **Teste do Desenho do Relógio:**

Avalia diversos domínios como funções executivas, memória, habilidades visuoespaciais, abstração e compreensão verbal. Tem a vantagem de ser de fácil aplicação.

Em uma folha em branca, orientar o paciente a desenhar um relógio com todos os ponteiros e números mostrando 2 horas e 45 minutos.

Avaliação: 10 a 6 – desenho do relógio e números corretos	
10	Ponteiros estão na posição correta
9	Leve erro nos ponteiros
8	Erros mais intensos nos ponteiros
7	Ponteiros completamente errados
6	Uso inapropriado dos ponteiros (uso de mostrador digital ou circulação de números, apesar de repetidas instruções)
Avaliação: 5 a 1 – desenho do relógio e números incorretos	
5	Números em ordem inversa ou concentrados em alguma parte do relógio. Ponteiros presentes de alguma forma
4	Distorção da sequência numérica, números faltando ou colocados fora dos limites do relógio
3	Números e mostrador não correlacionados. Ausência de ponteiros
2	Alguma evidência de ter entendido as instruções, mas o desenho apresenta vaga semelhança com um relógio
1	Não tentou ou não conseguiu representar um relógio



Condições emocionais

Escala de depressão Geriátrica (EDG/Yesavage/GDS), é utilizada para rastreio de quadros depressivos em idosos, pois, nesta faixa etária, as manifestações são muito atípicas.

A versão original é de 30 itens, mas há versões de 15, 10, 4 e 1 itens, sendo GDS 15 mais utilizada.

Obs: a EDG deve ser aplicada em idosos capazes de compreender as perguntas do questionário, não sendo adequada para pacientes sabidamente com déficit cognitivo.

■ **TABELA 9.3** Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – versão de 15 itens.

Perguntas	Sim		Não
1. Você está basicamente satisfeito com sua vida? (10, 4, 1)	0	1	
2. Você deixou muitos de seus interesses e atividades? (10, 4)	1	0	
3. Você sente que sua vida está vazia?	1	0	
4. Você se aborrece com frequência? (10)	1	0	
5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? (10)	0	1	
6. Você tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?	1	0	
7. Você se sente feliz a maior parte do tempo? (10, 4)	0	1	
8. Você sente que sua situação não tem saída? (10)	1	0	
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? (10, 4)	1	0	
10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?	1	0	
11. Você acha maravilhoso estar vivo?	0	1	
12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? (10)	1	0	
13. Você se sente cheio de energia? (10)	0	1	
14. Você acha que sua situação é sem esperanças?	1	0	
15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor do que você? (10)	1	0	

> 5 pontos: é sugestiva de depressão.

Obs: lembrar que testes não diagnosticam, sugerem. Apesar da realização dos testes tanto para detecção de demência quanto para depressão, é bom lembrar que eles têm caráter de rastreio e não de diagnóstico, devendo-se, então, utilizar os critérios da Classificação Internacional de Doenças (CID) e/ou do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM).

Sensorial

Os déficits sensoriais relacionados a **visão e audição** aumentam muito com o avançar da idade, tornando-se empecilho para a realização das atividades da vida diária (AVD).

Idosos com deficiência visual têm sua saúde e bem-estar comprometidos, pois podem perder sua carteira de motorista e sua independência, isolar-se socialmente, apresentar depressão, quedas com consequente redução da sua qualidade de vida.

A **perda auditiva** subdiagnosticada e, conseqüentemente, subtratada **interfere na validade e na confiabilidade das avaliações funcionais**, pois reduz pontos em testes de avaliação cognitiva, colocando pacientes em faixa de deficiência cognitiva e até demência. Além disso, essa perda está associada a maiores taxas de hospitalização, readmissão e eventos clínicos diversos, inclusive declínio cognitivo.

Obs: as deficiências relacionadas ao olfato e ao paladar também se acentuam com o envelhecimento e a capacidade discriminatória diminui. O desempenho em testes de capacidade olfatória tem uma correlação com os testes de avaliação cognitiva. Tanto as alterações olfatórias quanto do paladar influenciam na aceitação do paciente aos alimentos.

Fragilidade e Funcionalidade

▼ Capacidade intrínseca e funcional

Capacidade intrínseca é a soma de todas as capacidades físicas e mentais de uma pessoa em um dado momento.

Capacidade funcional diz respeito à interação do indivíduo com seu ambiente, funcionalidade é determinada através da sua autonomia e independência. É definida como a aptidão do idoso para realizar determinada tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente em seu meio.

Instrumentos para avaliação da funcionalidade:

- Atividades básicas de vida diária (ABVDs): índice de Barthel, Katz, escala ABVD;

■ **TABELA 9.4** Atividades básicas de vida diária (ABVD).

Cuidados pessoais	Comer
	Banhar-se
	Vestir-se
	Ir ao banheiro
Mobilidade	Andar com ou sem ajuda
	Transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa
	Mover-se na cama
Continência	Urinária
	Fecal

A Escala de Katz está incluída na maioria das avaliações multidimensionais. Sua elaboração é baseada na conclusão de que a

perda funcional segue um padrão igual de declínio, isto é, primeiro se perde a capacidade de banhar-se, seguida pela incapacidade de vestir-se, transferir-se e alimentar-se e, quando há recuperação, ela ocorre em ordem inversa.

TABELA 9.5 Avaliação das atividades básicas de vida diária (ABVD) – Escala de Katz.

1. Tomar banho (leito, banheira ou chuveiro) () Não recebe ajuda (entra e sai da banheira sozinho, se este for o modo habitual de tomar banho). (I) () Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (p. ex., as costas ou uma perna). (I) () Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo, ou não toma banho sozinho. (D)
2. Vestir-se (pega roupa, inclusive peças íntimas, nos armários e gavetas, e manuseia fecho, inclusive os de órteses e próteses, quando forem utilizadas). () Pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda. (I) () Pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para amarrar os sapatos. (I) () Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece parcial ou completamente sem roupa. (D)
3. Uso do vaso sanitário (ida ao banheiro ou local equivalente para evacuar e urinar; higiene íntima e arrumação das roupas) () Vai ao banheiro ou lugar equivalente, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda (pode usar objetos para apoio como bengala, andador ou cadeira de rodas e pode usar comadre ou urinol à noite, esvaziando-o de manhã). (I) () Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local equivalente, ou para se limpar ou para ajeitar as roupas após evacuação ou micção, ou para usar a comadre ou urinol à noite. (D) () Não vai ao banheiro ou equivalente para eliminação fisiológica. (D)
4. Transferências () Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda (pode estar usando objeto para apoio como bengala, andador). (I) () Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da cadeira com ajuda. (D) () Não sai da cama. (D)
5. Continência () Controla inteiramente a micção e a evacuação. (I) () Tem “acidentes” ocasionais. (D) () Necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação; usa cateter ou é incontinente. (D)
6. Alimentação () Alimenta-se sem ajuda. (I) () Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar carne ou passar manteiga no pão. (I) () Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado parcialmente ou completamente pelo uso de cateteres ou fluidos intravenosos. (D)

Obs: quanto mais pontos o paciente faz no teste, mais independente ele é.

- Atividades instrumentais de vida diária (AIVDs): Lawton, Pfeffer, escala AIVD.

Para uma vida independente e ativa na comunidade, executando as atividades rotineiras do dia a dia, o idoso deve usar os recursos disponíveis no meio ambiente. O conjunto dessas atividades foi denominado AIVD.

■ **TABELA 9.7** Atividades instrumentais de vida diária (AIVD).

Dentro de casa	Fora de casa
Preparar a comida	Manusear o dinheiro
Fazer as tarefas domésticas	Fazer compras
Lavar e cuidar do vestuário	Usar os meios de transporte
Executar trabalhos manuais	Deslocar-se (compromissos sociais, religiosos, ir ao médico)
Manusear medicação	
Usar o telefone	

Estão relacionadas com a realização de tarefas mais complexas, como arrumar a casa, telefonar, viajar, fazer compras, preparar os alimentos, controlar e tomar os remédios e administrar as finanças. De acordo com a capacidade de realizar essas atividades, é possível determinar se o indivíduo pode ou não viver sozinho sem supervisão.

A escala de Pfeffer é muito utilizada em nosso meio para avaliar se o déficit cognitivo é acompanhado de limitações funcionais.

■ **TABELA 9.8** Questionário de Pfeffer para atividades funcionais.

Perguntas	Pontos
1. Ele(a) é capaz de cuidar do seu próprio dinheiro?	
2. Ele(a) é capaz de fazer as compras sozinho (p. ex., de comida e roupa)?	
3. Ele(a) é capaz de esquentar água para café ou chá e apagar o fogo?	
4. Ele(a) é capaz de preparar comida?	
5. Ele(a) é capaz de manter-se a par dos acontecimentos e do que se passa na vizinhança?	
6. Ele(a) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio, televisão ou um artigo do jornal?	
7. Ele(a) é capaz de se lembrar de compromissos e acontecimentos familiares?	
8. Ele(a) é capaz de cuidar de seus próprios medicamentos?	
9. Ele(a) é capaz de andar pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa?	
10. Ele(a) é capaz de cumprimentar seus amigos adequadamente?	
11. Ele(a) é capaz de ficar sozinho(a) em casa sem problemas?	

Se:

- < 6 pontos: normal;
- ≥ 6 pontos: comprometido.

Nutrição

Vários são os fatores que podem alterar a nutrição do paciente:

- Morar sozinho: as vezes deixa de cozinhar pelo serviço, deixa de comer;
- Restrição funcional: podem incapacitá-lo de ir às compras e de cozinhar;
- Medicações.

Obs: além disso, pacientes em condições sociais adversas e do sexo masculino são mais suscetíveis aos quadros de desnutrição.

Ferramentas para avaliar a nutrição:

• **Mini Avaliação Nutricional (MAN);**

Tem a MAN reduzida (MNA-SF) também, geralmente mais utilizada.

O objetivo da MAN é avaliar o risco de desnutrição para poder intervir quando necessário. Inclui 18 itens, atingindo um escore máximo de 30 pontos, sendo que:

- 17-23,5: há risco de desnutrição;
- <17: desnutrição;
- >24: bom o estado nutricional.

Triagem	E. Problemas neuropsicológicos
A. Nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta alimentar em razão da perda de apetite, problemas digestivos, dificuldades para mastigar ou deglutir?	0 = Demência ou depressão grave
0 = Diminuição grave	1 = Demência leve
1 = Diminuição moderada	2 = Sem problemas neuropsicológicos
2 = Sem diminuição da ingesta	F1. Índice de massa corporal = [peso (kg)/altura (m)²]:
B. Perda de peso nos últimos 3 meses	0 = IMC < 19
0 = Superior a três quilos	1 = 19 ≤ IMC < 21
1 = Não sabe informar	2 = 21 ≤ IMC < 23
2 = Entre um e três quilos	3 = IMC ≥ 23
3 = Sem perda de peso	Se o cálculo do IMC não for possível, substituir a questão F1 pela F2
C. Mobilidade	F2. Circunferência da panturrilha (CP) em cm
0 = Restrito ao leito ou à cadeira de rodas	0 = CP < 31
1 = Deambula, mas não é capaz de sair de casa	1 = CP ≥ 31
2 = Normal	Pontuação de triagem (máximo 14 pontos)
D. Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses?	12 a 14 pontos: estado nutricional normal
0 = Sim	08 a 11 pontos: sob risco de desnutrição
2 = Não	0 a 7 pontos: desnutrição

IMC: índice de massa corporal. (Fonte: Guigoz, 2006; Kaiser *et al.*, 2009; Nestlé Nutrition Institute, 2009.)

Condições socioambientais

Esta talvez seja a dimensão mais complexa e difícil de ser quantificada, provavelmente pela heterogeneidade dos seus componentes. Devem ser avaliadas as relações e as atividades sociais, os recursos disponíveis de suporte (social, familiar e financeiro), sabendo com que tipo de ajuda o idoso pode contar, caso necessite. Esses fatores influenciam diretamente o planejamento terapêutico.

Necessidade de adaptação do ambiente. Avaliar quem é o cuidador, se é treinado, se está sob estresse.

- **Apgar da família e dos amigos:**

- < 3 pontos: acentuada disfunção nas relações familiares e de amizade;
- 4 a 6 pontos: moderada disfunção nas relações familiares e de amizade;
- > 6 pontos, disfunção leve ou ausente.

■ **TABELA 9.10** Apgar da família e dos amigos.

Está satisfeito e pode contar com seus familiares (amigos) para resolver seus problemas?	0 – Raramente 1 – Ocasionalmente 2 – Frequentemente
Está satisfeito com a forma com que seus familiares (amigos) conversam e compartilham os problemas com você?	0 – Raramente 1 – Ocasionalmente 2 – Frequentemente
Está satisfeito com a forma com que seus familiares (amigos) acatam e apoiam suas vontades e decisões?	0 – Raramente 1 – Ocasionalmente 2 – Frequentemente
Está satisfeito com a forma com que seus familiares (amigos) expressam afeição e respondem às suas emoções, como raiva, sentimentos de culpa, medo, afeto?	0 – Raramente 1 – Ocasionalmente 2 – Frequentemente
Está satisfeito com a forma com que você e seus familiares (amigos) compartilham o tempo juntos?	0 – Raramente 1 – Ocasionalmente 2 – Frequentemente

Polifarmácia

Uso de 5 ou mais medicamentos estariam mais relacionados a desfechos negativos. Portanto, a polifarmácia, muitas vezes, não é errada, e sim necessária, mas não deixa de ser uma situação de risco, pois existe uma relação direta entre o número de medicamentos usados e o risco de eventos adversos, incluindo aqueles mais graves com óbito.

Avaliação de medicações inapropriada, ou seja, sem evidência clara de benefício e com risco aumentado excedendo os benefícios.

Podemos avaliar por:

- Critério de Beers 2019 – atualizado 2023 e 2025;
- STOPP/START;
- Teste da sacola de remédios.

■ **TABELA 9.11** Teste da sacola de remédios.

Solicitar no agendamento da consulta que o paciente ou acompanhante traga uma sacola com todos os medicamentos em uso pelo paciente
Mostrar cada medicamento e perguntar a posologia, há quanto tempo usa e para que foi indicado
Perguntar sobre outros medicamentos utilizados recentemente (último mês) e sobre a suspensão ou mudança de dosagem de algum medicamento
Perguntar sobre o uso de medicação injetável, tópica ou aerossóis, de remédios naturais, fitoterápicos, vitaminas e sobre automedicação
Insistir sobre o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, sedativos e hipnóticos, antiveriginosos, antigripais e antialérgicos
Perguntar sobre a relação entre introdução, aumento ou redução de dose e suspensão de algum medicamento com: declínio funcional, confusão mental, quedas, incontinência

Comorbidades e multimorbidade

Comorbidades: doenças que se sobrepõe combinando/potencializando efeitos de outra.

Multimorbidade: ocorrência de duas ou mais doenças crônicas.

Podemos avaliar por:

- **Charlson Comorbidity Index:** mais utilizado para estudos, analisa a carga de doenças do paciente.

Relação maior de mortalidade em quem tem mais doenças (obviamente).

Escore mortalidade em 1 ano:

- 0 ponto (12%);
- 1 a 2 pontos (26%);
- 3 a 4 pontos (52%);
- ≥ 5 pontos (85%)

■ **TABELA 9.12** Índice de comorbidade-idade de Charlson (ICIC).

Peso	Condição clínica
1	Infarto do miocárdio Insuficiência cardíaca congestiva Doença vascular periférica Demência Doença cerebrovascular Doença pulmonar crônica Doença do tecido conjuntivo Diabetes melito leve, sem complicação Úlcera péptica
2	Hemiplegia Doença renal grave ou moderada Diabetes melito com complicação Tumor Leucemia Linfoma
3	Doença do fígado grave ou moderada
6	Tumor maligno, metástase AIDS
Ponderação da idade	
Grupo etário	Pontos
0 a 49	0
50 a 59	1
60 a 69	2
70 a 79	3
80 a 89	4
90 a 99	5

Outros parâmetros

- **Autoavaliação da saúde:** pede para o paciente o que ele acha da saúde dele. Notou-se que piores avaliações relacionados a piores desfechos em alguns estudos;

Uma sugestão é perguntar ao paciente o que ele acha de sua saúde e mostrar as seguintes opções: muito boa, boa, regular, ruim, muito ruim e sem condições (quando o paciente não tem condições de responder).
- Avaliação e investigação de possíveis **maus-tratos** sempre que suspeita;
- **Estimativa de risco cardiovascular.**

Triagens para AGA

A AGA pode ser feita pelo médico em seu consultório, no entanto, é mais bem realizada por uma equipe interdisciplinar, nos diferentes locais de atendimento ao

idoso, como pronto-socorro, enfermaria, centro de reabilitação, ambulatório, clínicas de outras especialidades e em programas de atendimento domiciliar.

- G8: para neoplasias hematológicas;

É um instrumento desenvolvido para pacientes com neoplasias hematológicas e que consta de 8 perguntas retiradas da miniavaliação nutricional (MAN) somadas a um item que divide os idosos em três grupos etários (menos que 80 anos, entre 80 e 85 anos e maiores que 85 anos). O escore máximo é de 17 pontos e valores menores ou iguais a 14 são indicativos de risco e justificam a realização da avaliação geriátrica.

- aCGA: Abbreviated Comprehensive Geriatric Assessment;

Composta por três questões sobre AVD, quatro questões sobre AIVD, quatro questões do MEEM e quatro questões da EDG.

Diferente de outros instrumentos de triagem, não há uma pontuação de corte, e sim recomendações dependendo das dificuldades. São elas:

- EDG ≥ 2 : completar a EDG de 15 pontos;
 - Dificuldade em AVD: completar a avaliação das AVD;
 - Dificuldade em AIVD: completar a avaliação das AIVD;
 - Pontuação no rastreio cognitivo ≤ 6 : completar o MEEM
- **VES-13 ou VES-20:** Vulnerable Elders Survey, usado para rastreio de idosos vulneráveis na comunidade.

Os critérios estabelecidos pelos autores para definir vulnerabilidade foram: idade ≥ 65 anos e alto risco de declínio funcional ou morte em 2 anos.

É composto de quatro partes. A primeira é a idade, a segunda é uma pergunta sobre autoavaliação de saúde, a terceira é composta de seis perguntas sobre atividades físicas e a quarta de cinco perguntas sobre AVD.

O escore máximo é de 10 pontos e valores ≥ 3 indicam vulnerabilidade, suscitando a aplicação da AGA.

Resumo do resumo

Avaliamos:

- **Força motora:**

- Avaliação neurológica
- Mobilidade:
 - Get up and go: classificamos de 1-5;
 - Get up and go cronometrado: <10s normal, 10-19s possível alteração e >19s alterado;
 - Equilíbrio e marcha.

- Sarcopenia:

Pode ser classificada pelo EWGSOP (1 sarcopenia possível, 1+2 sarcopenia e 1+2+3 sarcopenia grave) ou pelo SARC-F ≥ 4 indica sarcopenia.

Avaliamos:

- Força muscular: preensão palmar → alterado se <27 kg em homens e <16 kg em mulheres;
- Massa muscular: circunferência da panturrilha da perna não dominante → alterado se <31 cm;
- Desempenho muscular: velocidade da marcha → alterado de <0,8 m/s.

- **Função cognitiva:**

- MEEM → alterado se <20-29, depende da escolaridade;
- Moca → alterado se <24/25 se escolaridade >4 anos;
- Teste do relógio → menor número mais acometimento.

- **Condição emocional:**

- EDG → >5 pontos sugestivo de depressão.

- **Sensorial:** avaliar visão e audição, especialmente;

- **Fragilidade e funcionalidade:**

- ABVD: avalia pelo Katz → quanto mais pontos mais independente;
- AIVD: avalia pelo Pfeffer → ≥ 6 alterado.

- **Nutrição:**
 - MAN → <17 desnutrição e 17-23 risco de desnutrição.
- **Socioambiental:**
 - APGAR familiar → <3 acentuada disfunção, 4-6 moderada disfunção, >6 disfunção leve ou ausente.
- **Polifarmácia:** pode avaliar os medicamentos pelos critérios de BEERS ou teste da sacola de medicamentos;
- **Comorbidades e multimorbidades:**
 - Charlson Comorbidity Index: quanto mais pontos maior a mortalidade em 1 ano.